

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE SITUACIONES SOCIALES (ISS-30)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Dimensional de las Habilidades Sociales y la Asertividad

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Situaciones Sociales (ISS: 30 reactivos).
Nombre Original	Inventario de Situaciones Sociales (ISS; Guaygua & Roth, 2008).
Autores Originales	Lic. Mariana Guaygua y Dr. Erick Roth (2008), Universidad Católica Boliviana.
Publicación Primaria	<i>Ajayu: Revista de Divulgación Científica en Psicología</i> , 6(2), 125-148.
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Habilidades Sociales, Asertividad y Manejo de Conflictos.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de evaluación conductual de 30 reactivos con escala Likert de 5 puntos (A a E / 1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 14 años). Estudiantes, ámbito laboral y clínica ambulatoria.
Tiempo de Administración	6 a 10 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, docente y de investigación bajo citación formal.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO CONDUCTUAL DE HABILIDADES SOCIALES

El ISS se fundamenta en la teoría del aprendizaje social y los modelos conductuales de la competencia interpersonal (Bandura, 1977; Caballo, 1993; Kelly, 2002). El constructo de **habilidad social** se define como el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresan sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas mismas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la interacción minimizando la probabilidad de futuros conflictos.

El ISS fue diseñado y estandarizado específicamente para el contexto hispanoparlante, superando las discrepancias transculturales de los inventarios anglosajones. Operacionaliza las situaciones cotidianas en cuatro áreas clave de desempeño interpersonal:

- Defensa de Derechos Personales:** Negativa asertiva ante peticiones irracionales, decir “no” a amistades o familiares y reclamar ante injusticias.
- Expresión de Afecto y Apoyo Social:** Habilidad para brindar consuelo en duelo, elogiar a otros y aceptar reconocimientos.
- Inicio y Mantenimiento de Interacciones:** Acercamiento a personas desconocidas, interacciones románticas y sociabilidad grupal.
- Manejo de Situaciones Conflictivas y Crítica:** Afrontar el desacuerdo, responder a hostilidades, disculparse y tolerar opiniones discrepantes.

Neurobiológicamente, el déficit de asertividad se asocia a hiperreactividad de la amígdala ante señales faciales de desaprobación social y a una débil activación de la corteza prefrontal ventrolateral durante la regulación del miedo interpersonal.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Área de Habilidad Social	Ítems (30)	Nº Ítems	Definición Operativa y Conducta Evaluada
1. Defensa de Derechos	3, 4, 5, 10, 17, 20, 25	7 ítems	Decir “no”, negar préstamos, reclamar devoluciones y poner límites.
2. Expresión de Afecto	1, 8, 16, 27	4 ítems	Dar apoyo en duelo, transmitir optimismo y recibir elogios.
3. Iniciativa e Interacción	14, 15, 21, 29, 30	5 ítems	Iniciar charlas con extraños, citas y acercamiento al sexo opuesto.
4. Manejo de Conflictos	2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28	14 ítems	Responder a hostilidad, pedir explicaciones, disculparse y sostener discrepancias.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN POBLACIÓN HISPANA

Consistencia Interna	Excelente precisión métrica: coeficiente alfa de Cronbach global de 0.89 a 0.92 en la muestra de validación (Guaygua & Roth, 2008). Las cuatro subescalas muestran alfas entre 0.74 y 0.85. Fiabilidad test-retest $r = 0.82$ a 4 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial ratifica de forma concluyente una estructura de cuatro dimensiones oblicuas intercorrelacionadas que explican el 51.8% de la varianza total, con cargas factoriales saturando entre 0.42 y 0.78.
Validez Concurrente y Criterio	Correlación directa robusta con medidas de ansiedad social (LSAS, $r = 0.54$), timidez y déficit asertivo en la Escala de Rathus (RAS, $r = -0.58$). Correlación inversa con autoestima y bienestar interpersonal.
Sensibilidad al Entrenamiento	Sensibilidad demostrada en programas de Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS) y TCC grupal, evidenciándose reducciones significativas de la dificultad subjetiva ($d > 0.80$) tras 10 sesiones de role-playing.
Diferencias de Género	Se observan diferencias contextuales: los varones reportan mayor dificultad en expresión de afecto y vulnerabilidad (Ítems 1, 22), mientras que las mujeres reportan mayor dificultad en defensa de derechos frente a figuras de autoridad (Ítems 5, 20).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 30 reactivos describe una situación cotidiana y se responde indicando el grado de dificultad percibida según las claves:

- **Clave de Calificación:** A = «Nunca me cuesta / Ninguna dificultad» (**1 punto**); B = «Pocas veces» (**2 puntos**); C = «Algunas veces» (**3 puntos**); D = «Muchas veces» (**4 puntos**); E = «Siempre me cuesta / Máxima dificultad» (**5 puntos**).
- **Paso 1 (Cálculo Directo):** No contiene reactivos invertidos; todos los ítems puntúan de 1 a 5 en la dirección del déficit o dificultad subjetiva.
- **Paso 2 (Puntuación Total ISS-30):** Suma de los 30 reactivos: $\text{Puntuación Total} = \sum_{i=1}^{30} \text{Ítem}_i$.
- **Rango Teórico Global: 30 a 150 puntos.** A mayor puntuación, mayor severidad de la dificultad interpersonal y déficit de asertividad.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS NORMATIVOS (GUAYGUA & ROTH, 2008)

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Competencia Social	Conducta Asistencial Recomendada
Asertivo / Óptimo	30 a 65 puntos	Alta habilidad social y asertividad	Excelente desenvolvimiento; sabe defender derechos y expresar afecto con soltura.
Moderado / Medio	66 a 95 puntos	Inhibición situacional / Media	Dificultades circunscritas ante estresores o figuras de alta jerarquía. Psicoeducación.
Déficit Clínico	96 a 120 puntos	Déficit manifiesto (corte ≥ 96)	Inhibición conductual recurrente; alta sumisión. Indicación de Entrenamiento en Habilidades Sociales.
Severo / Grave	121 a 150 puntos	Inhibición social generalizada / Fobia	Parálisis social severa; incapacidad para fijar límites; alto aislamiento. TCC intensiva.

VALOR CLÍNICO DE LA SUBESCALA DE DEFENSA DE DERECHOS (ÍTEMS 3, 4, 5, 10, 17, 20, 25):

Una puntuación media ≥ 4.0 en este factor (respuestas D o E sistemáticas) define al paciente con **estilo interpersonal sumiso pasivo**. La persona cede a peticiones gravosas por terror al conflicto o al rechazo, convirtiéndose en terreno fértil para el agotamiento psicosomático, la depresión por indefensión y el resentimiento acumulado.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN ENTRENAMIENTO ASERTIVO (EHS)

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL PERFIL DEL ISS-30:

- **Paso 1 (Detección del Foco de Inhibición):** Identificar los reactivos con puntuación 4 o 5. Jerarquizar una lista de situaciones temidas (desde reclamar un producto defectuoso hasta decir "no" a un préstamo familiar).
- **Paso 2 (Ensayo Conductual y Modelado):** Entrenamiento sistemático en consulta mediante role-playing: contacto ocular, tono de voz firme, técnica del disco rayado, banco de niebla y aserción negativa.
- **Paso 3 (Exposición en Vivo Graduada):** Asignar tareas conductuales reales en el entorno del paciente (ej. devolver un artículo comercial, pedir explicaciones breves ante una cita tardía).
- **Paso 4 (Monitorización):** Un descenso de **≥ 25 puntos** en el total del ISS-30 tras 10 semanas consolida la autonomía asertiva del paciente.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN INHIBICIÓN SOCIAL Y ANSIEDAD LABORAL

Identificación: Mujer de 29 años, administrativa en entidad bancaria, acude por cefaleas tensionales crónicas, insomnio y angustia los domingos. Relata incapacidad para negarse a realizar tareas ajenas ("mis compañeros me piden favores abusivos y siempre digo que sí por miedo a que se enfaden conmigo").

Evaluación Inicial ISS-30 (Línea Base): Puntuación Total = **114/150 puntos** (Rango de Déficit Clínico Manifiesto). Factores más alterados: Defensa de Derechos = **33/35 puntos** (ítems 3, 4, 5, 17 puntuados con 5); Manejo de Conflictos = **52/70 puntos** (máximo bloqueo ante el enfado ajeno).

Plan Terapéutico: 10 sesiones de Entrenamiento en Asertividad y Habilidades Sociales (EHS). Se practicaron respuestas asertivas directas frente a demandas laborales inapropiadas, reestructurando la creencia irracional de que "decir que no es ser una mala persona".

Reevaluación a las 10 Semanas: Puntuación Total ISS-30 descendió a **58/150 puntos** (-56 pts, normalización al Rango Asertivo Óptimo). Defensa de Derechos bajó a **14/35 puntos**. La paciente comunicó haber rechazado con serenidad dos sobrecargas laborales abusivas, desapareciendo la sintomatología tensional.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ASERTIVIDAD VS. AGRESIVIDAD REACTIVA:

Al entrenar asertividad en pacientes pasivos crónicos, es común observar un balanceo inicial hacia conductas excesivamente bruscas o agresivas como sobrecompensación. Moldear cuidadosamente la firmeza con respeto empático.

DESCARTE DE FOBIA SOCIAL GENERALIZADA:

Si la dificultad en situaciones sociales (ISS > 120) se acompaña de rubor intenso, temblores somáticos y evitación fóbica anticipatoria de cualquier interacción pública, evaluar formalmente Trastorno de Ansiedad Social (DSM-5 / LSAS).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Guaygua, M., & Roth, E. (2008). Desarrollo y adaptación del Inventario de Situaciones Sociales (ISS): Validación factorial, de criterio y cálculo de confiabilidad. *Ajayu: Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología*, 6(2), 125-148.
2. Caballo, V. E. (1993). *Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales*. Siglo XXI de España Editores.
3. Kelly, J. A. (2002). *Entrenamiento de las habilidades sociales: Guía práctica para intervenciones*. Desclée de Brouwer.
4. Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.